

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Infection urinaire / Cystite suspectée

Conduite à tenir devant symptômes urinaires évocateurs, avec prudence chez le résident âgé, sondé ou complexe.

Indications

- Brûlures mictionnelles, pollakiurie, urgenturie, gêne ou douleur sus-pubienne.
- Absence de signe haut ou tableau compatible avec infection urinaire basse.
- Modification clinique compatible avec infection urinaire réellement symptomatique.

Vérifications préalables

- Prendre température et rechercher douleur lombaire, frissons, vomissements ou sepsis.
- Évaluer confusion, rétention, globe, déshydratation et état général.
- BU/ECBU selon organisation locale, procédure interne et/ou avis médical.
- Vérifier sonde urinaire, grossesse possible, antécédents et antibiothérapie récente.

Ne pas appliquer ce protocole

- Fièvre $\geq 38,5$ °C, frissons, douleur lombaire ou sepsis suspect.
- Altération importante de l'état général, hypotension, vomissements ou confusion aiguë.
- Homme, sonde urinaire, grossesse ou résident complexe sans avis médical.
- Simple BU positive sans symptôme compatible.

Conduite à tenir

- Renforcer l'hydratation si possible et surveiller l'état général.
- Prévenir le médecin pour décision diagnostique, ECBU et traitement.
- Antibiotique uniquement sur prescription nominative ou protocole local validé.
- Tracer BU/ECBU, température et apparition éventuelle de signes hauts.

Surveillance et traçabilité

- Tracer symptômes, température, BU/ECBU éventuels et appel médical.
- Noter traitement instauré, tolérance et évolution clinique.
- Surveiller signes de gravité, douleur lombaire, fièvre ou décompensation.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si persistance, fièvre, confusion ou aggravation.
- Appel 15 si sepsis suspect, douleurs lombaires intenses, altération de conscience ou état de choc.

Mention de sécurité

Une BU positive isolée ne suffit pas à traiter. Distinguer colonisation/asymptomatique et infection réellement symptomatique.

Fait à :

Le : / /

Signature :